COMPRENDRE • UE B2 / S1

Psychologie de la santé

Psychologie de la santé • représentations, stress et comportements • source Moodle

Comprendre les comportements de santé

La psychologie de la santé étudie les liens entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux dans la santé, la maladie, l'adaptation et les conduites de soin. Connaître une recommandation ne suffit pas à la suivre : les croyances, l'histoire, les ressources et les contraintes de vie modulent le passage du savoir à l'action.

Du biomédical au biopsychosocial

Le modèle biomédical reste essentiel pour diagnostiquer et traiter une atteinte corporelle. Le modèle biopsychosocial d'Engel (1977) l'élargit : facteurs biologiques (symptômes, physiologie), psychologiques (émotions, représentations, coping) et sociaux (famille, culture, revenus, accès aux soins) interagissent.

Rôle infirmier

Explorer la situation singulière avant de qualifier une personne de « non observante ». Chercher ce qui facilite ou empêche l'action, puis négocier un objectif réaliste avec elle.

Exemple d'analyse

Pour une personne vivant avec un diabète, la maladie peut être biologiquement stable tout en étant vécue comme une menace, une contrainte ou un événement peu crédible. Les routines de travail, le coût, les repas partagés et le soutien des proches influencent aussi les possibilités d'action. Le raisonnement biopsychosocial évite de confondre prescription et faisabilité.

Dimension	Exemple à explorer
Biologique	Symptômes, traitements, fatigue, effets ressentis
Psychologique	Représentation, émotions, confiance, expérience antérieure
Sociale	Entourage, ressources, culture, horaires, accès

Repère clinique

Un diagnostic décrit une atteinte ; il ne décrit pas à lui seul ce que la maladie signifie pour la personne ni ce qu'elle peut faire dans son contexte.

COMPRENDRE • UE B2 / S1

Psychologie de la santé

Psychologie de la santé • représentations, stress et comportements • source Moodle

Représentations : le sens donné à la maladie

Une représentation est une manière de comprendre et d'expliquer la santé ou la maladie, construite par l'expérience, la famille, la culture, les médias et les échanges sociaux. Elle oriente ce qui paraît dangereux, utile ou acceptable.

Moscovici et Herzlich

Les représentations sociales sont partagées et évoluent dans les groupes. Herzlich décrit des façons qualitativement différentes de vivre la maladie (par exemple comme destructrice, libératrice ou comme métier/expérience à gérer) : ce sont des repères d'analyse, pas des catégories diagnostiques.

Quand patient et soignant divergent

Le conseil peut être exact mais inadéquat s'il ne répond pas aux priorités du patient. Demander : « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? », « Que signifie ce diagnostic pour vous ? », « Qu'est-ce qui vous semble faisable ? »

Évaluer avant de conclure

Le modèle de Selye distingue alarme, résistance et épuisement, mais le modèle transactionnel précise que deux personnes peuvent évaluer différemment le même événement. Le coping est un processus dynamique : la personne tente une stratégie, en observe l'effet, puis réévalue la situation et ses ressources.

Si le patient dit…	Piste d'exploration
« Ce n'est pas grave »	Vulnérabilité et gravité perçues
« Je n'y arriverai pas »	Obstacles, ressources et auto-efficacité
« Je veux changer mais… »	Ambivalence, stade et soutien disponible

COMPRENDRE • UE B2 / S1

Psychologie de la santé

Psychologie de la santé • représentations, stress et comportements • source Moodle

Stress : une transaction personne–environnement

Pour Lazarus et Folkman (1984), le stress ne dépend pas seulement de l'événement : il naît de son évaluation par la personne. Évaluation primaire : menace, perte, défi ou neutralité ? Évaluation secondaire : quelles ressources et quels moyens sont disponibles ?

Coping : faire face

Le coping regroupe les efforts cognitifs et comportementaux déployés pour gérer une situation évaluée comme exigeante. Centré sur le problème : planifier, demander une information ou une aide ciblée, agir sur la situation. Centré sur l'émotion : réguler le vécu, prendre du recul, chercher du soutien.

La stratégie dépend du contrôle possible

Une stratégie n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Agir sur le problème est utile si la situation peut changer ; lorsque l'action directe n'est plus possible, accepter, s'apaiser ou mobiliser un proche peut être plus adapté. Le soutien social est une ressource importante.

Choisir le bon point d'appui

Une intention ne garantit pas le changement. Avec le Health Belief Model, explorer séparément le risque ressenti, la gravité, les bénéfices, les coûts et les déclencheurs. Avec les stades du changement, une personne en précontemplation a surtout besoin d'exploration et de dialogue ; l'action planifiée vient lorsque la personne se sent prête.

Situation contrôlable	Situation peu contrôlable
Planifier, chercher une information, résoudre une difficulté, solliciter une aide ciblée.	Apaiser l'émotion, prendre du recul, accepter l'attente, mobiliser un soutien.
Réévaluer ce qui a changé.	La flexibilité vaut mieux qu'une seule stratégie.

Famille	Question utile
Problème	Qu'est-ce qui peut être modifié ?
Émotion	Qu'est-ce qui aiderait à traverser cette situation ?
Soutien	Qui ou quoi peut aider ?

COMPRENDRE • UE B2 / S1

Psychologie de la santé

Psychologie de la santé • représentations, stress et comportements • source Moodle

Croyances et changement

Le Health Belief Model (Rosenstock, puis Becker) examine : vulnérabilité perçue, gravité perçue, bénéfices attendus, obstacles perçus, signaux d'action et sentiment d'efficacité personnelle. Un obstacle concret (effet redouté, coût, oubli, horaires) peut peser plus qu'une information générale.

Stades du changement

Le modèle transthéorique de Prochaska et DiClemente distingue précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien et rechute. La trajectoire n'est pas linéaire ; une rechute ne signifie pas l'absence d'apprentissage. Adapter l'accompagnement au stade réel, sans précipiter l'action.

Auto-efficacité et locus de contrôle

Bandura : croyance de pouvoir réussir une action précise, renforcée par des expériences de réussite, des étapes atteignables, des modèles et un retour soutenant. Rotter : attentes concernant l'origine des conséquences (locus plutôt interne ou externe). Ces repères aident à personnaliser l'accompagnement sans réduire la personne à un « manque de volonté ».

Renforcer la capacité d'agir

L'auto-efficacité porte sur une tâche concrète, pas sur la valeur globale de la personne. Les expériences de réussite progressive et les exemples de pairs peuvent la renforcer. Le locus de contrôle renseigne sur les attentes concernant l'influence personnelle ou celle du contexte ; il ne permet pas de juger la motivation. En stage, suivre avec le patient un objectif réaliste, ses obstacles et son évolution.

Repère	Ce qu'il aide à questionner
HBM	Pourquoi l'action paraît-elle nécessaire ou coûteuse ?
Stades du changement	La personne envisage-t-elle le changement ou agit-elle déjà ?
Bandura / Rotter	Se sent-elle capable ? À quoi attribue-t-elle les résultats ?

Source Moodle : Psychologie de la santé • représentations, stress et comportements • UE B2 / S1. Repères de pratique à articuler aux protocoles de l'établissement et à l'encadrement de stage.